



HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

MESURER

& AMÉLIORER LA QUALITÉ

RAPPORT DE CERTIFICATION

HOPITAL TENON - AP- HP SORBONNE UNIVERSITE

4 RUE DE LA CHINE
75970 Paris



Validé par la HAS en Janvier 2023

Ce document ainsi que sa référence bibliographique sont téléchargeables sur www.has-sante.fr



Haute Autorité de santé – Service communication et information
5 avenue du Stade de France – 93218 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX. Tél. : +33 (0)1 55 93 70 00
© Haute Autorité de santé – Janvier 2023

Sommaire

Préambule	4
Décision	7
Présentation	8
Champs d'applicabilité	9
Résultats	10
Chapitre 1 : Le patient	11
Chapitre 2 : Les équipes de soins	13
Chapitre 3 : L'établissement	15
Table des Annexes	20
Annexe 1. Liste des établissements géographiques rattachées à la démarche	21
Annexe 2. Synthèse des activités réalisées par l'établissement en 2023	22
Annexe 3. Programme de visite	23

Préambule

La certification, mission confiée à la Haute Autorité de Santé (HAS) par les ordonnances de 1996, est une procédure d'évaluation externe des établissements de santé publics et privés effectuée par des professionnels (des pairs) mandatés par la HAS : les experts-visiteurs. Cette procédure quadri-annuelle, indépendante de l'établissement et de ses organismes de tutelle, porte sur le niveau de qualité et de sécurité des soins délivrés aux patients. Obligatoire, elle est codifiée à l'article L6113-3 (et suivants) du code de la santé publique.

La certification constitue une des modalités de mesure de la qualité des soins en établissements de santé et vise l'appropriation des standards de la qualité par les établissements. Elle y favorise également la mise en œuvre d'une dynamique d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Elle est une certification globale et non une certification de toutes les activités de l'établissement. En effet, le dispositif porte sur le fonctionnement global de l'établissement et n'a pas vocation à évaluer spécifiquement le fonctionnement de chaque secteur d'activité.

Elle fournit une évaluation de la qualité et de la sécurité des soins des établissements de santé aux usagers et aux Agences régionales de santé (ARS) sans se substituer aux inspections et contrôles de sécurité sanitaire menés par ces autorités de tutelle.

Cette démarche nationale est réalisée selon des standards internationaux : la procédure de certification est elle-même évaluée par l'International Society for Quality in Health Care via l'International Accreditation Program (IAP), le seul programme international qui accrédite les organismes qui accréditent des structures de soins. La HAS a obtenu de l'ISQua en 2018 le renouvellement de son accréditation pour son activité de certification.

Une évaluation qui s'appuie sur un référentiel élaboré par la HAS en concertation avec les professionnels de santé, les organisations représentatives et les représentants des usagers...

Chaque établissement de santé est évalué sur les critères génériques, s'appliquant à tout l'établissement, ainsi que sur des critères spécifiques relevant :

- de populations spécifiques : enfant et adolescent, patient âgé, personne en situation de handicap,
- de modes de prise en charge spécifiques : ambulatoire, hospitalisation à domicile (HAD), SAMU-SMUR, urgences, soins critiques (soins continus, soins intensifs et réanimation)
- de secteurs d'activités spécifiques : chirurgie et interventionnel, maternité, psychiatrie et santé mentale, soins de suite et de réadaptation (SSR), unité de soins de longue durée (USLD).

Ce référentiel, publié sur le site Internet de la HAS, comprend des critères ayant des niveaux d'exigence différents :

- des critères standards correspondent aux attendus de la certification;
- des critères impératifs correspondent à ce que l'on ne veut plus voir au sein d'un établissement de santé. Ils ont un impact particulier dans la décision de certification. En effet, si une évaluation de l'un de ces critères est négative pour un ou plusieurs de ses éléments d'évaluation, la HAS se réserve le droit de ne pas accorder la certification de l'établissement.
- des critères avancés correspondent à des exigences souhaitées mais non exigibles à ce jour. Ils correspondent potentiellement aux critères de certification de demain et sont valorisés pour les établissements qui peuvent y répondre sous condition d'un niveau minimal sur l'ensemble des critères standards et impératifs.

| ... et sur des méthodes

- des patients traceurs pour évaluer la qualité et la sécurité de la prise en charge d'un patient dans l'établissement de santé
- des parcours traceurs pour évaluer la continuité et la coordination de la prise en charge des patients, le travail en équipe et la culture qualité et sécurité au cours d'un parcours de soins défini
- des traceurs ciblés pour évaluer la mise en œuvre d'un processus ciblé
- des audits systèmes pour évaluer les organisations de l'établissement et s'assurer de leur maîtrise sur le terrain
- des observations pour évaluer les conditions générales de qualité et de sécurité des soins.

| Un rapport de certification structuré en 3 chapitres

Les résultats des évaluations réalisées durant une visite de l'établissement par des experts-visiteurs se traduisent dans un rapport de visite articulé en cohérence avec les 3 chapitres du référentiel.:

- Le premier chapitre concerne directement le résultat pour le patient. Tout au long de sa prise en charge, ses droits sont respectés, ses besoins spécifiques pris en compte de la même façon que ses attentes et ses préférences. Au-delà, l'engagement du patient est recherché. Son implication comme partenaire de sa prise en charge, tout comme celle de ses proches et aidants, est favorisée par l'expression de son point de vue sur son expérience et le résultat des soins.
- Le deuxième chapitre concerne les équipes de soins, à tous les niveaux. La certification vise à apprécier leur capacité à rechercher la pertinence, l'efficacité et la sécurité des soins, à se concerter et se coordonner tout au long du parcours du patient. Elle met également l'accent sur la maîtrise des risques liés au soin. Les analyses des événements indésirables associés aux soins, notamment les événements indésirables graves ainsi que des rapports de certification précédents conduisent à mettre un accent particulier sur le risque infectieux et le risque lié aux médicaments.
- Le troisième chapitre concerne l'établissement et sa gouvernance (direction et commission/conférence médicale d'établissement). Cette dernière favorise l'insertion territoriale en lien avec les autres acteurs de l'offre de soins et médico-sociale. Elle impulse une dynamique forte d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins qui associe et soutient les équipes, ainsi que les patients, représentants d'usagers et associations de malades.

Cette structuration permet l'analyse croisée entre le résultat pour le patient, les pratiques mises en œuvre par les équipes de soins et la dynamique impulsée par la gouvernance de l'établissement et du groupement, le cas échéant.

| Une décision et un rapport rendus publics

Sur la base du rapport de visite, complété d'éventuelles fiches d'anomalies et des observations de l'établissement, la HAS adopte le rapport de certification et rend une décision. La HAS peut prononcer trois types de décision :

- une décision de certification valable quatre ans qu'elle peut assortir d'une mention ;
- une décision de non-certification impliquant la mise en œuvre d'une nouvelle procédure dans un délai maximum de deux ans ;
- une décision de certification sous conditions ; une nouvelle procédure est alors programmée dans un délai compris entre six et douze mois. À l'issue de cette seconde procédure, la HAS constate si l'établissement a rempli les conditions pour être certifié. Elle prononce alors une décision de certification, avec ou sans mention, ou une décision de non-certification.

Le rapport et la décision sont publiés sur le site Internet de la HAS et communiqués à l'autorité de tutelle de l'établissement.

L'établissement doit en assurer la plus large diffusion interne. Il doit notamment la porter à la connaissance des instances délibérantes, de la commission ou conférence médicale d'établissement et de la commission des usagers.

Ce rapport de visite est produit par l'équipe des experts-visiteurs dans un délai d'une quinzaine de jour après la fin des évaluations et de la réunion de restitution, il est transmis à l'établissement pour que celui-ci puisse formuler ses observations. Il sera remis également à la HAS et fera partie des éléments de référence pour l'élaboration du rapport de certification

Décision

Au vu des éléments mentionnés dans le présent rapport, issus de la visite sur site, la Haute Autorité de santé décide la certification de l'établissement.

Présentation

HOPITAL TENON - AP-HP SORBONNE UNIVERSITE	
Adresse	4 RUE DE LA CHINE 75970 Paris Cedex 20 FRANCE
Département / Région	Paris / Ile-de-france
Statut	Public
Type d'établissement	CHU / CHR

Établissement(s) juridique(s) rattaché(s) à cette démarche (la liste des établissements géographiques se trouve en annexe 1)

Type de structure	N° FINESS	Nom de l'établissement	Adresse
Établissement juridique	750712184	ASSISTANCE PUBLIQUE- HOPITAUX DE PARIS	3 AVENUE VICTORIA 75184 PARIS CEDEX 04 FRANCE

Synthèse des activités réalisées par l'établissement au 2023

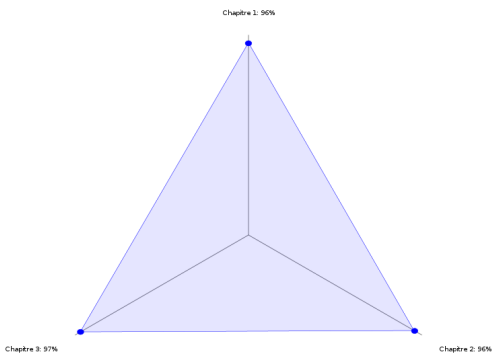
Vous trouverez en annexe 2 l'ensemble des activités réalisées par l'établissement.

Champs d'applicabilité

Champs d'applicabilité
Adulte
Ambulatoire
Chirurgie et interventionnel
Enfant et adolescent
Hospitalisation complète
Maladie chronique
Maternité
Médecine
Pas de situation particulière
Patient âgé
Patient atteint d'un cancer
Patient en situation de handicap
Patient en situation de précarité
Programmé
Psychiatrie et santé mentale
Soins critiques
Tout l'établissement
Urgences

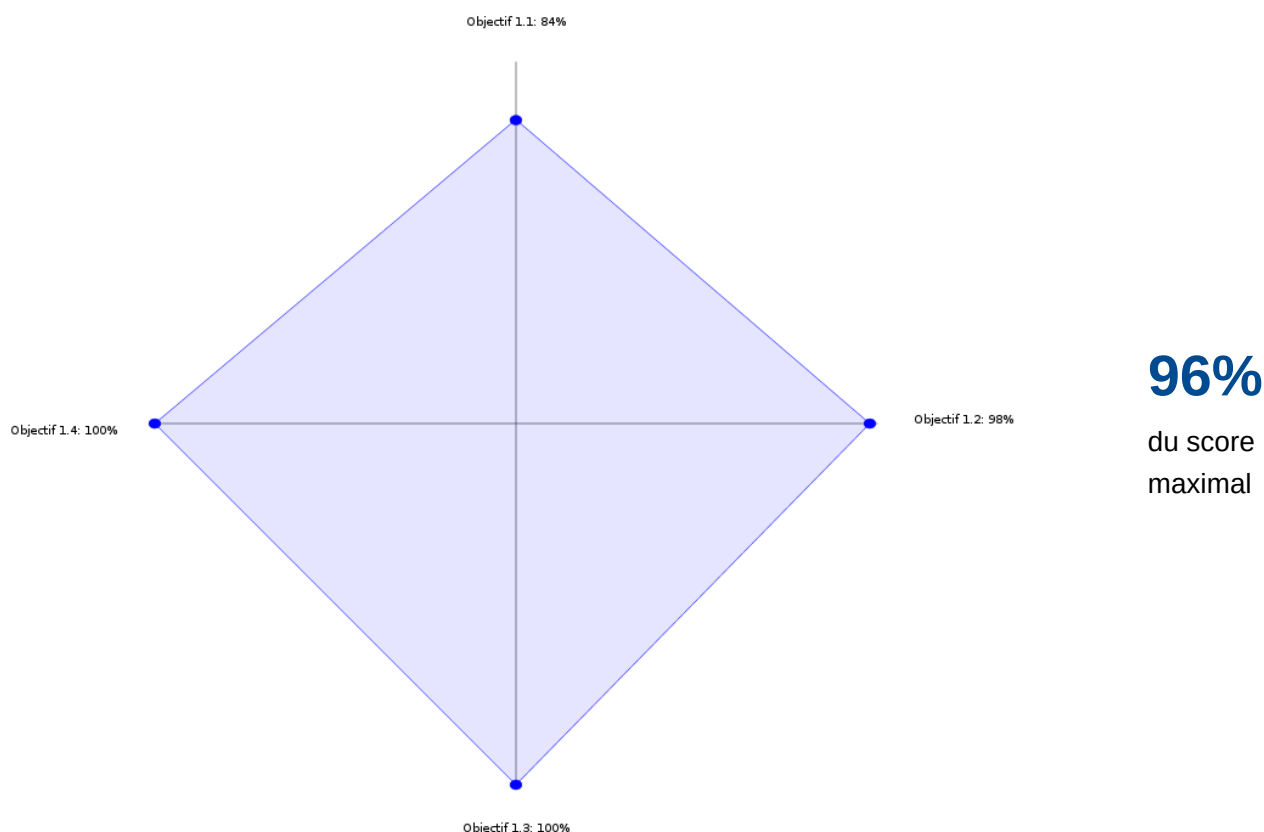
Au regard du profil de l'établissement, [121](#) critères lui sont applicables

Résultats



Chapitre	
Chapitre 1	Le patient
Chapitre 2	Les équipes de soins
Chapitre 3	L'établissement

Chapitre 1 : Le patient

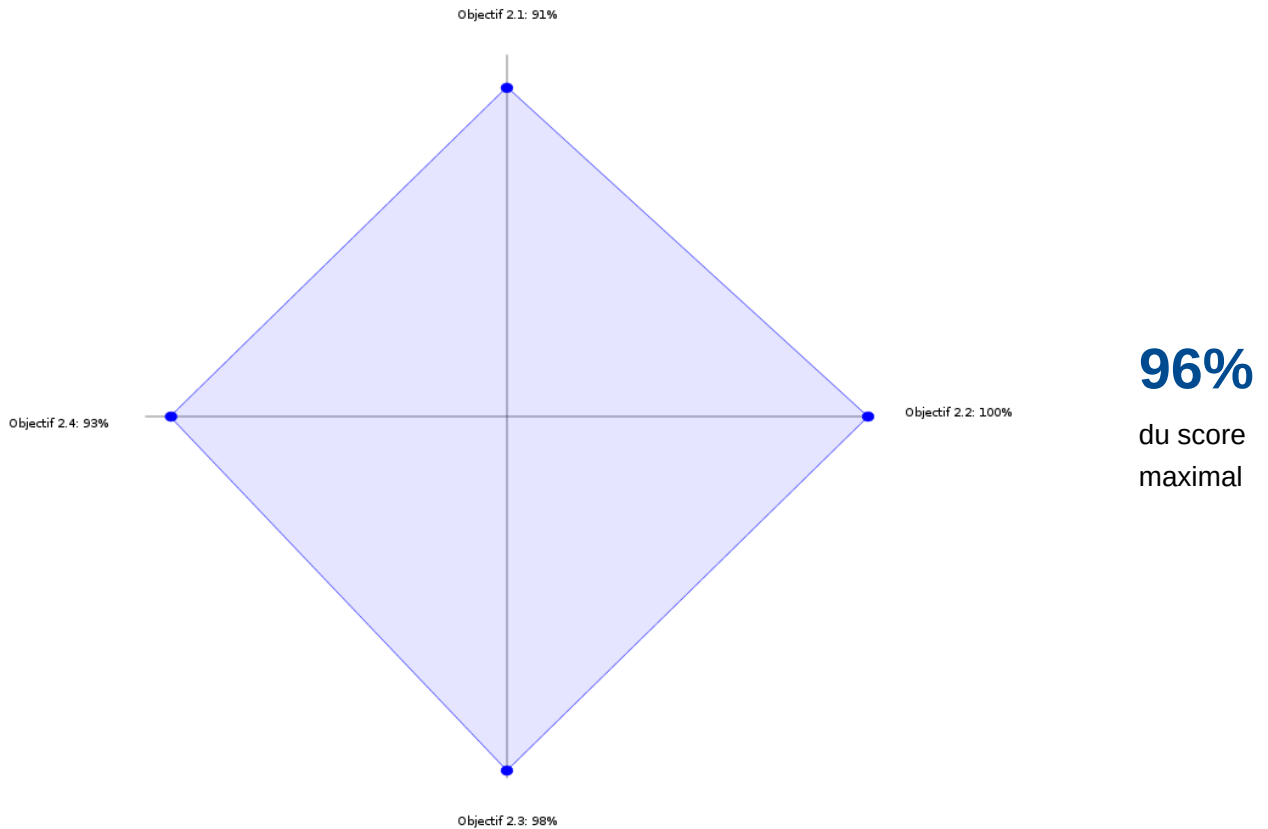


Objectifs		
1.1	Le patient est informé et son implication est recherchée.	84%
1.2	Le patient est respecté.	98%
1.3	Les proches et/ou aidants sont associés à la mise en œuvre du projet de soins avec l'accord du patient	100%
1.4	Les conditions de vie et de lien social du patient sont prises en compte dans le cadre de sa prise en charge	100%

La politique du Centre Hospitalier de Tenon appartenant au Groupe Hospitalier Sorbonne Université de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris a induit une application du respect des droits des patients dans tous les secteurs. Les comportements des professionnels sont adaptés à la pathologie du patient, à son handicap et permettent de respecter son intimité et sa dignité. L'établissement a développé les chambres à un lit. Cependant, il y a des services dans lesquels persistent des chambres à deux lits. En période d'affluence, les zones d'attentes des urgences ne permettent pas toujours de respecter l'intimité. Dans quelques services (par exemple pneumologie, psychiatrie, il n'y a pas de douche individuelle). Les locaux sont adaptés d'une façon générale aux différents types de handicaps et permettent la libre circulation des personnes à mobilité réduite. Dans les services concernés par le manque de douche et/ou par les chambres à 2 lits, des travaux

d'humanisation sont prévus sans date précise. Le projet de naissance est élaboré et pris en compte par les professionnels de la salle naissance. Les parents sont bien informés de la prise en charge de leur enfant et leur participation active aux soins est effective. En plus des salles d'accouchements conventionnelles et des salles de blocs d'urgence, le service est équipé d'une salle d'accouchement physiologique. L'accueil, la prise en charge, le traitement et l'organisation de la sortie des patients précaires sont une des préoccupations fortes de l'établissement. Un dispositif rapide d'accès aux EHPAD est mis en œuvre. Plusieurs services sont labellisés « hospitalité » par exemple les transports, l'ambulatoire, ... « Le label Hospitalité de l'AP-HP est attribué à une unité hospitalière volontaire, dès lors que celle-ci réunit des critères définis sur sept champs complémentaires du soin technique tels que l'accueil ou la qualité de la relation ». Le patient est informé par le livret d'accueil et les professionnels. De nombreux documents spécifiques aux services ou à la prise en charge sont donnés aux patients. De nombreuses brochures sont traduites en plusieurs langues. Les diverses chartes et informations sont affichées et sont en adéquation avec le type de prise en charge. L'information médicale est retrouvée notamment dans la lettre de sortie sur les modifications du traitement médicamenteux de sortie. Un film sur le déroulé de la prise en charge de l'ambulatoire est disponible pour les patients concernés. L'implication du patient est recherchée pendant le parcours de soins, il exprime son consentement libre et éclairé sur son projet de soins et ses modalités. Les proches et/ou aidants sont associés à la mise en œuvre du projet avec l'accord du patient. Les coordonnées et le nom de la personne de confiance et de la personne à informer sont retrouvés dans les dossiers. La traçabilité de l'acceptation par la personne de confiance est rarement retrouvée. L'information sur la transfusion sanguine est effectuée oralement mais le document scriptural n'est pas donné systématiquement au malade. Les respects de la dignité et de la confidentialité du patient sont assurés par les professionnels pendant tout le parcours du patient y compris pendant les transports et les gestes techniques. Les conditions de vie et de lien social du patient sont prises en compte dans le cadre de sa prise en charge et notamment lors de la sortie. Le maintien de l'autonomie est une préoccupation des professionnels de l'établissement. Une salle de rééducation contribue au maintien de l'autonomie des patients de cours séjour gériatrique. Aux urgences, les temps d'attente moyens sont communiqués par l'infirmière d'accueil. Dans le service de psychiatrie, les restrictions de liberté respectent les règles de bonnes pratiques. Les contentions sont prescrites et réévaluées. Les patients mineurs bénéficient d'un environnement adapté. Pour les patients souffrant de maladie chronique telle la drépanocytose des liens sont organisés entre le service de pédiatrie de Trousseau et le secteur adulte pour faciliter la prise en charge et l'adaptation du patient. L'avis des représentants des usagers est pris en compte notamment pour la mise en place d'actions d'amélioration. Les représentants sont connus par les professionnels mais pas toujours par les patients qui ne connaissent que rarement les modalités pour effectuer des directives anticipées. La douleur du patient est évaluée régulièrement et prise en charge avec un traitement adapté cependant il a été constaté que des prescriptions d'antalgiques « si besoin » n'étaient pas étayées sur la base d'une échelle reconnue.

Chapitre 2 : Les équipes de soins

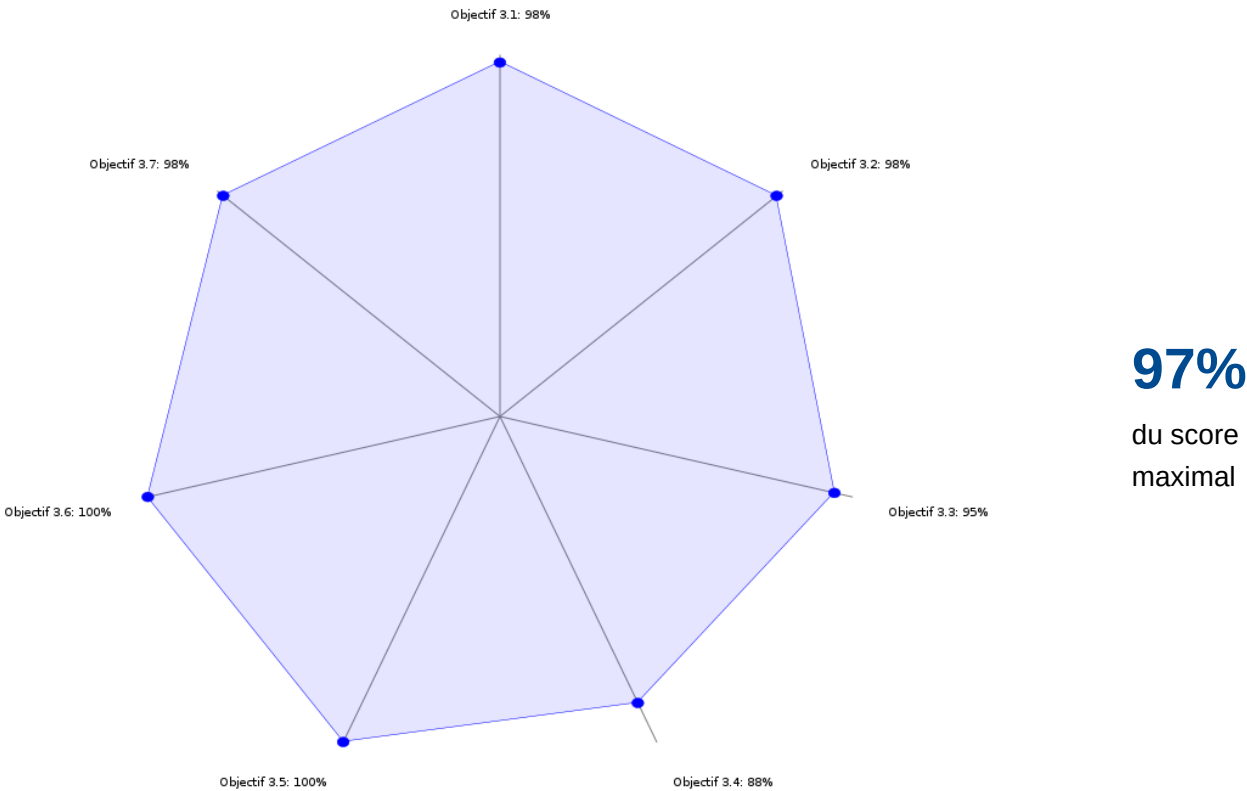


Objectifs		
2.1	La pertinence des parcours, des actes et des prescriptions est argumentée au sein de l'équipe	91%
2.2	Les équipes sont coordonnées pour prendre en charge le patient de manière pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire tout au long de sa prise en charge	100%
2.3	Les équipes maîtrisent les risques liés à leurs pratiques	98%
2.4	Les équipes évaluent leurs pratiques notamment au regard du suivi des résultats cliniques de leur patientèle	93%

L'Hôpital Tenon prend en charge des patients sur l'ensemble des filières : Médecine, chirurgie, obstétrique et psychiatrie. Le parcours du patient est coordonné afin de garantir la qualité et la sécurité des soins. La prise en charge des patients est multi professionnelle : La traçabilité de la coordination et de l'ensemble des professionnels est retrouvée dans les dossiers patients. Plusieurs équipes mobiles interviennent sur l'établissement notamment une gériatrique (avec une infirmière en pratique avancée), une de soins palliatifs, une pour l'antibiothérapie et une contre la douleur, ... Le dossier du patient est complètement informatisé dans la plupart des services. Il contient tous les éléments nécessaires à la prise en charge : Recueil de données, antécédents, allergies, motifs d'hospitalisation, traitement, comorbidités, résultats de bilans, personne de confiance... Tous les intervenants tracent leurs actions thérapeutiques ou préventives (Kinésithérapeute,

psychologue, assistante sociale...). La sortie est organisée en amont avec l'équipe. Pour la réanimation, le déploiement de l'informatisation est planifié et organisé dès février 2023 avec le démarrage de la formation des professionnels. L'établissement de Tenon est engagé dans plusieurs programmes d'éducatifs thérapeutiques parmi lesquels : VIH, hépatite, pneumologie, dialyse (...) et un programme labellisé sur les neuro-modulateurs et l'autosondage. L'établissement a mis en place une lutte contre les infections nosocomiales notamment par les interventions d'une équipe d'hygiéniste. La lutte contre l'antibiorésistance est organisée notamment par une justification et une réévaluation systématique de la prescription entre 48h et 72h. Ces points sont retrouvés dans les dossiers. Une équipe mobile de spécialistes et un guide pratique des anti infectieux permettent d'obtenir une aide pour ces prescriptions. Les bonnes pratiques d'antibioprophylaxie liées aux actes invasifs sont maîtrisées par les équipes. Si l'argumentation des transfusions sanguines est bien tracée dans les dossiers, il n'a pas été retrouvé d'évaluation de la pertinence des transfusions au niveau de l'établissement. Les contentions sont systématiquement prescrites argumentées et réévaluées. Les règles de vérification de l'identité sont définies. Les patients bénéficient tous d'un bracelet d'identification blanc, pour les personnes allergiques ce bracelet est rouge. La prise en charge médicamenteuse respecte les règles de bonnes pratiques. Une conciliation médicamenteuse est initiée dans quelques services. Les prescriptions sont informatisées dans la plupart des unités. Tous les comprimés ou gélules sont correctement identifiés. Les médicaments à risque sont correctement identifiés. L'administration médicamenteuse est effectuée par les infirmières qui vérifient la prescription et tracent l'administration (ou la non administration) sur informatique ou sur papier en temps réel... Dans des services, réanimation par exemple où l'informatisation de la prise en charge médicamenteuse n'est pas encore mise en place, il a été constaté dans les dossiers observés que les règles de prescriptions administration respectaient les règles de bonnes pratiques. Les médicaments à risque sont connus des professionnels, ils sont étiquetés de façon spécifique et rangés à part dans la pharmacie. Une liste de ces molécules est établie et affichée. La vérification des péremptions est régulière et tracée. Le circuit des chimiothérapies est informatisé et sécurisé pour l'ensemble des étapes du circuit mais le logiciel Chimio n'est pas interfacé avec le logiciel du dossier patient ; la feuille de prescription /administration pour les chimiothérapies est imprimée et les infirmières tracent l'administration sur cette feuille. Des audits sur la prise en charge médicamenteuse ont eu lieu. Les transports intra hospitaliers sont effectués avec du matériel adapté. Ils respectent les règles d'hygiène, d'identification, de confort et de respect de l'intimité des patients. Ce service est labellisé. Au niveau de la maternité, de nombreux indicateurs qualité et sécurité des soins sont suivis. Une salle césarienne est disponible, l'équipe de la maternité maîtrise l'urgence obstétricale dont le risque de l'hémorragie du post-partum. Les urgences disposent de circuits appropriés au type d'urgence. Une revue des radiologies effectuées sur ce secteur est mise en œuvre. L'environnement au bloc opératoire et du secteur d'endoscopies est conforme en matière de propreté, d'hygiène et de maîtrise du risque infectieux. Au bloc opératoire la check-list « sécurité patient », est réalisée mais il n'y a pas eu d'évaluation des « go et no go ». Il n'y a pas d'indicateurs de suivi de surveillance des infections des sites opératoires depuis 2020. La sortie du patient est organisée en fonction de son autonomie et en lien avec l'aval qui est destinataire le jour même d'une fiche de liaison de sortie ou d'un compte rendu complet. Les patients externes des urgences sortent aussi avec un compte rendu de passage. Les indicateurs qualité et sécurité des soins sont suivis et connus par les professionnels. Des Revues de Morbi Mortalité et des RCP sont en place. Il y a des retours d'expérience dans tous les services. Des audits sur l'hygiène, la tenue du dossier, ... sont effectués et suivis de plans d'actions.

Chapitre 3 : L'établissement



Objectifs		
3.1	L'établissement définit ses orientations stratégiques en cohérence avec son territoire	98%
3.2	L'établissement favorise l'engagement des patients individuellement et collectivement	98%
3.3	La gouvernance fait preuve de leadership	95%
3.4	L'établissement favorise le travail en équipe et le développement des compétences	88%
3.5	Les professionnels sont impliqués dans une démarche de qualité de vie au travail impulsée par la gouvernance	100%
3.6	L'établissement dispose d'une réponse adaptée et opérationnelle aux risques auxquels il peut être confronté	100%
3.7	L'établissement développe une dynamique d'amélioration continue de la qualité des soins	98%

Le Groupe Hospitalier Sorbonne Université Coopération territoriale : Les 39 établissements qui constituent l'AP-HP sont regroupés en six GHU (Groupement Hospitalo-Universitaire), dans lesquels sont définis des DMU (Département Médico-universitaire) multi-sites en remplacement des pôles. Le GHU Sorbonne Université, constitué des hôpitaux Charles-Foix, Pitié-Salpêtrière, Rothschild, Saint-Antoine, Tenon et Trousseau - La

Roche-Guyon, comporte 13 DMU. Les GHU ont été définis avec les doyens des universités selon les filières universitaires, en concordance avec les parcours et les prises en charge des patients. Le cadre général et les orientations stratégiques sont donnés par le siège de l'APHP. Ainsi, les objectifs pour la période 2021-2025 sont recensés dans le projet d'établissement de l'AP-HP qui comprend le projet médical, le projet de soins et le projet qualité Gestion des Risques. Il existe une Commission Centrale de Concertation avec les Usagers (3CU), composé de représentants des usagers de l'ensemble des GHU. Chaque GHU décline ensuite ses politiques dans son propre projet d'établissement pour la période 2021-2025, en cohérence avec les orientations de l'AP-HP, selon les besoins de son territoire. L'AP-HP est dérogoire au droit commun et ne constitue pas l'établissement support des GHT d'Ile-de-France. Les GHU ont des conventions d'association avec les GHT. Le GHU Sorbonne Université a ainsi des conventions d'association avec les GHT 77 Nord et GHT 77 Sud. La coordination avec la ville est un axe majeur pour le GHU Sorbonne Université. Des admissions directes sont possibles notamment sur des parcours complexes pour éviter les passages aux urgences, et une concertation est mise en place avec les professionnels de ville ou les acteurs sociaux comme le SAMU Social. 20 à 30% des admissions sont réalisées directement du domicile du patient ou de l'EHPAD vers les services de gériatrie aigue, de SSR ou de psychiatrie du GHU. Différentes équipes mobiles hospitalières sont déployées sur les secteurs de ville, EHPAD ou sur les établissements de santé en gériatrie, MPR, santé mentale, périnatalité, appui aux parcours... Une collaboration est développée avec les CPTS et les médecins libéraux. Cette coordination est appuyée par une politique de ressources humaines médicales à destination des territoires sous-denses, avec 24 postes de médecins partagés sur des spécialités médicales, et 61 postes partagés sur différents établissements d'Ile de France. La psychiatrie est un autre axe prioritaire du GHU Sorbonne Université, qui propose une prise en charge sur la vie entière à destination des enfants, des adolescents et des adultes jusqu'à la géronto-psychiatrie. Le GHU est par ailleurs une référence dans la prise en charge de l'autisme : diagnostic, prise en charge enfants, adolescents et adultes, équipe mobile, formations des professionnels de ville, et USIDATU (Unité Sanitaire Interdépartementale d'Accueil Temporaire d'Urgence) à compétence régionale. Le Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR) est mis à jour quotidiennement par une équipe de régulation, qui alerte de la gouvernance en cas de tension. Une équipe médico-soignante assure l'appui de la fluidification des parcours des patients, en lien avec les structures HAD et de ville, et les acteurs institutionnels (ARS, conseil local de santé de la ville de Paris, justice, etc.). Le GHU Sorbonne Université est un groupement de référence dans la prise en charge des patients en situation de handicap avec la création d'une prise en charge spécifique « Handi-consult » pour les patients en échec de prise en charge en ville, ainsi que dans la prise en charge des patients malentendants à l'UNISS. La télé-expertise a été particulièrement développée durant la crise sanitaire, notamment en cardiologie, en diabétologie ou en hépatologie (jusqu'à 30% de l'activité). Engagement patient : L'engagement du patient est un axe du projet stratégique du GHU Sorbonne Université, en lien avec le projet d'établissement de l'AP-HP. L'établissement s'emploie à développer l'écoute envers les patients afin d'améliorer les organisations. L'expertise patient est quant à elle impulsée par l'université des patients, délivrant des DU et master class formant les patients experts. A ce jour, environ 350 patients ont été formés. Des enseignements dirigés pour les étudiants en médecine sont dispensés par un médecin accompagné d'un patient. Les représentants des usagers sont impliqués dans le management du GHU, en lien avec la gouvernance, sur les quatre axes du projet des usagers. Ils sont déclinés sur chaque établissement et suivis en Commission Des Usagers : information du patient, écoute et prise en considération du patient, hospitalité empathique, accompagnement en cas de vulnérabilités. Plusieurs cafés du rétablissement permettent des échanges entre des patients rétablis avec des patients en cours de prise en charge. La promotion de la bientraitance est un engagement de la gouvernance du GHU Sorbonne Université, inscrite dans le projet de soins et le projet qualité 2021-2025. Elle se décline dans le projet de soins du patient qui se veut individualisé, la mise en place de réunions pluridisciplinaires, l'évaluation de la satisfaction du patient (e-satis, suivi des réclamations, patients-traceurs, questionnaires, Verbatim...), la mise en place d'une commission de support éthique dans chaque établissement, l'amélioration des conditions hôtelières. Le GHU s'est engagé dans la démarche Label Hospitalité, fondée sur la perception

de l'utilisateur. Près d'une centaine de label Hospitalité ont été décernés sur le GHU Sorbonne Université. Le GHU met en place des outils dédiés au dépistage de la maltraitance en pédiatrie et chez l'adulte, qui permettent l'identification des situations complexes avec implication des aidants. Le DMP et l'espace numérique en santé sont alimentés (lorsque l'utilisateur en a ouvert) directement par le dossier patient informatisé pour 98% des documents émis. Dynamique d'amélioration et gestion des risques : La qualité et gestion des risques est intégrée dans le projet d'établissement et déclinée dans les différents projets. Les objectifs sont établis au niveau des services de soins, avec une contractualisation au niveau des DMU et un suivi annuel en conférence stratégique. Le pilotage de la démarche qualité s'appuie sur un réseau de professionnels, les comités et commissions des vigilances. La Qualité Gestion des Risques est déclinée au sein des DMU par établissement et services. La gestion documentaire est unique pour l'ensemble du GHU. Des binômes référents Qualité Risques et cadre supérieur de santé sur chaque hôpital du GHU permettent l'animation de la démarche qualité au sein des services par l'intermédiaire de réunions, de rencontres de professionnels médicaux et non médicaux au niveau de l'établissement et du DMU. Une démarche d'accréditation d'équipe des secteurs d'imagerie est en cours sur le GHU Sorbonne Université. Les démarches d'évaluation sont organisées sous forme d'audits (armoires à médicaments, bracelet d'identification, chariots d'urgence, checklist au bloc opératoire...). La dynamique a été freinée par la crise COVID mais l'impulsion est reprise notamment par la préparation des visites de certification. Des actions d'amélioration des pratiques ou des prises en charge des patients peuvent faire l'objet d'une prime d'engagement collectif, ou bénéficier de financements spécifiques dans le cadre d'appels à projets financés par l'AP-HP (fonds APRES). Les plans des Situations Sanitaires Exceptionnelles (SSE) sont déclinés par établissement, et font l'objet d'exercices réguliers. Une commission SSE au niveau du GHU est en cours de constitution. La stratégie relative au développement durable est définie pour la période 2021-2025. Elle se décline en actions de sensibilisation auprès des professionnels (sur les maternités, perturbateurs endocriniens, tri des déchets). Le GHU a analysé son bilan carbone à deux reprises, la dernière fois en 2022. Des actions spécifiques ont été menées comme l'arrêt de l'utilisation de gaz avec impact carbone important aux blocs opératoires. Des actions sont également menées afin d'économiser les énergies (récupération des eaux de pluie, mise en place d'énergies renouvelables comme une chaufferie avec biomasse). La sécurisation du système d'information est organisée avec changement régulier des mots de passe, une revue régulière des accès, la sécurisation d'internet, une charte d'utilisation du système d'information. L'ensemble des médecins est incité à utiliser la messagerie sécurisée MSSanté dans le cadre de ses relations avec les professionnels de ville et les autres établissements.

QVT, travail en équipe et leadership : La politique QVT portée par la gouvernance est basée sur le dialogue, avec des actions sur les services de soins afin d'être porteur de sens. En 2021, Sorbonne Université a conduit un travail majeur visant à diffuser une culture QVT au sein du groupe hospitalier, faisant figure de pilote pour les autres établissements de l'AP-HP. Un COPIL QVT, co-présidé par la Directrice Générale du groupe hospitalier et le président de la commission médicale d'établissement locale, a défini un plan d'action reprenant les propositions faites par un groupe de travail rassemblant des managers médecins et paramédicaux. Ainsi, 6 axes (management ; temps d'échange formels et informels au sein des services ; diffusion de l'information ; intégration ; harmonisation des organisations et des pratiques ; bien-être) et 56 actions concrètes ont été définies et se déclinent dans le cadre du projet d'établissement. Des référents QVT relaient les différentes actions menées au sein de chaque DMU. Les actions de formation en management pour les professionnels médicaux comme paramédicaux sont renforcées, comme par exemple le coaching. Elles bénéficient notamment aux nouveaux responsables afin qu'ils puissent développer leur leadership. Pour les nouveaux professionnels, médicaux et non médicaux, des temps d'accueil et d'intégration sont prévus, notamment à des fins de fidélisation. Le Groupe Hospitalier s'emploie à développer une politique de détermination des cibles en emploi et effectifs pour tous les services et tous les métiers (maquettes organisationnelles et tableaux de service ; gestion prévisionnelle des effectifs ; gestion du temps de travail et temps de présence au travail). La gestion du remplacement des absences passe par une mutualisation des compétences et le redéploiement des professionnels au sein de chaque site et de chaque DMU. Concernant les RPS, de nombreux dispositifs sont à

la disposition des professionnels, qui peuvent par ailleurs s'appuyer sur des instances dédiées (par exemple, la commission médicale de Vie Hospitalière pour les médecins). La politique RH donne un certain degré de délégation de gestion aux DMU, via le plan de formation et la promotion professionnelle. Des outils d'évaluation de la charge de travail et des organisations adaptées sont mis en œuvre, pouvant aboutir à des audits. Le travail en équipe est promu. Une expérimentation PACTE a été menée en 2015 sur deux établissements (hôpitaux Tenon et Saint Antoine) mais n'a pas été poursuivie. L'hôpital Tenon est un hôpital de proximité. L'établissement collabore avec les autres sites de l'AP-HP. Un partenariat est organisé avec des EHPAD, des cliniques pour l'aval des urgences et le CPTS du 20^{ème} arrondissement. L'établissement est aussi référent pour la prise en charge de la drépanocytose. L'établissement s'emploie à développer l'écoute des patients afin d'améliorer les organisations. Cependant, le peu de réponses aux questionnaires de satisfaction (e-Satis) a induit le site à envisager de développer de nouvelles enquêtes de satisfaction sur le terrain. Les résultats des enquêtes de satisfaction des patients sont connus par le management et l'encadrement de proximité mais peu par les équipes de soins. Chaque service a analysé les verbatim des questionnaires de son service. L'expertise patient est développée et intégrée dans des programmes ou des actions d'éducatons thérapeutiques. L'expertise patient est aussi retrouvée lors de séance d'information où les patients interviennent pour faire part de leur connaissance, par exemple séances d'informations destinée aux professionnels sur les personnes transsexuelles, prise en charge du cancer, ... Les représentants des usagers de l'hôpital Tenon sont intégrés en son sein et bénéficie d'une écoute de la direction. Les actions qu'ils préconisent sont mises en œuvre. Les coordonnées des représentants des usagers sont affichées et diffusées. Cependant, les patients hospitalisés interrogés ne les connaissaient pas. Les représentants des usagers sont impliqués dans l'amélioration de la qualité de la prise en charge notamment par la participation à des audits, à l'analyse des plaintes et à la prise de connaissance des déclarations d'événements indésirables. Un projet des usagers est intégré dans le projet d'établissement. La promotion de la bientraitance est un engagement de la gouvernance du GHU Sorbonne Université et de celle Tenon. Tous les professionnels rencontrés avaient été sensibilisés à cette problématique. Des démarches d'évaluation ont été organisées sous forme d'audits et de traceurs. La culture du signalement est promue au sein de l'établissement et l'analyse des événements indésirables est suivie d'un plan d'actions d'amélioration dont le suivi est effectif. Les équipes et le management sont impliqués dans la démarche d'amélioration et de la sécurité des soins. L'évaluation de la culture qualité et sécurité des soins est en projet. La politique de la qualité de vie au travail et la démarche pour le travail en équipe sont promues par le management et favorisés par l'encadrement de proximité. Les exercices de simulation en équipe, l'accréditation par l'OECI « Comprehensive Cancer Center » en cancérologie, l'accréditation des équipes de radiologie, font partie de ce processus. La synchronisation des temps médicaux et paramédicaux, le soutien psychologique des professionnels en cas de difficultés, le tutorat pour les juniors paramédicaux et médicaux contribuent à l'amélioration de la qualité de vie au travail. Les plans des Situations Sanitaires Exceptionnelles (SSE) sont déclinés par l'établissement, et font l'objet d'exercices. Une commission SSE au niveau du GHU est en cours de constitution. Sur le site Tenon, le Plan Blanc est formalisé et connu par les professionnels. La prise en charge des urgences vitales est organisée avec un numéro d'appel affiché et connu des professionnels. Le matériel pour la prise en charge des urgences vitales est disponible et régulièrement vérifié. Le numéro à appeler est affiché et connu des professionnels. Des formations sont engagées y compris des simulations en équipe. Les formations des professionnels et le suivi des mises à jour sont effectifs, de plus des exercices de simulation sur la prise en charge des urgences vitales sont organisées au sein de services. Les chariots d'urgence sont régulièrement vérifiés. La stratégie relative au développement durable est définie pour la période 2021-2025. Elle se décline en actions de sensibilisation auprès des professionnels. Le GHU a analysé son bilan carbone à deux reprises, la dernière étant en 2022. Des actions spécifiques ont été menées comme l'arrêt de l'utilisation de gaz avec effet de serre aux blocs opératoire ou sur la maternité par la réalisation d'un audit sur les produits contenant des perturbateurs endocriniens et mises en place d'actions pour supprimer ces produits au sein du service, sur le reste du site passage au nettoyage vapeur, mise en place de ruches, ... La sécurisation du système d'information est

organisée avec changement régulier des mots de passe et des solutions dégradées en cas d'attaque informatique. Les professionnels connaissent ces solutions dégradées et la situation géographique de l'ordinateur de sauvegarde (réplique des dossiers informatisés) à utiliser en cas de panne du système. Les médecins utilisent une messagerie sécurisée. Suite à la crise covid, l'hôpital tenon a des postes vacants, notamment pour les IDE, mais est parvenu à minimiser les fermetures de lits et l'impact sur l'aval des urgences, en faisant un travail sur le remplacement et en le sécurisant en élaborant des flyers d'accueils pour les intérimaires et en vérifiant leur niveau de connaissance du logiciel informatique.

Table des Annexes

- Annexe 1. Liste des établissements géographiques rattachées à la démarche
- Annexe 2. Synthèse des activités réalisées par l'établissement en 2023
- Annexe 3. Programme de visite

Annexe 1. Liste des établissements géographiques rattachées à la démarche

Type de structure	N° FINESS	Nom de l'établissement	Adresse
Établissement juridique	750712184	ASSISTANCE PUBLIQUE- HOPITAUX DE PARIS	3 AVENUE VICTORIA 75184 PARIS CEDEX 04 FRANCE
Établissement principal	750100273	HOPITAL TENON - AP-HP	4 RUE DE LA CHINE 75970 Paris Cedex 20 FRANCE

Annexe 2. Synthèse des activités réalisées par l'établissement en 2023

Catégorie / Champs d'applicabilité / Donnée de profil	Valeur
---	--------

Annexe 3. Programme de visite

Nb	Méthode	Sous-méthode	Champs d'applicabilité	Description traceur
1	Parcours traceur		Tout l'établissement Chirurgie et interventionnel Enfant et adolescent Patient âgé Soins critiques Urgences Adulte Pas de situation particulière Hospitalisation complète	
2	Parcours traceur		Tout l'établissement Ambulatoire Enfant et adolescent Patient atteint d'un cancer Patient âgé Adulte Médecine Hospitalisation complète Programmé	
3	Audit système	Entretien Professionnel		
4	Audit système	Entretien Professionnel		
5	Audit système	Entretien Professionnel		
6	Traceur ciblé	Prévention des infections associées aux soins		Dispositif médical réutilisable : endoscopie

7	Parcours traceur		Tout l'établissement Patient âgé Patient en situation de précarité Maladie chronique Psychiatrie et santé mentale Adulte Hospitalisation complète Programmé	
8	Patient traceur		Tout l'établissement Ambulatoire Patient en situation de handicap Adulte Médecine Programmé	
9	Traceur ciblé	Circuit du médicament et des produits de santé		Prescription intégrant, a minima, un médicament à risque per os
10	Traceur ciblé	Circuit du médicament et des produits de santé		Prescription intégrant, a minima, un antibiotique injectable
11	Traceur ciblé	Circuit du médicament et des produits de santé		Prescription intégrant, a minima, a minima, un médicament à risque injectable
12	Traceur ciblé	Circuit du médicament et des produits de santé		Prescription intégrant, a minima, un antibiotique injectable
13	Patient traceur		Tout l'établissement Patient âgé Urgences Médecine Pas de situation particulière Hospitalisation complète	

14	Traceur ciblé	Circuit du médicament et des produits de santé		Prescription intégrant, a minima, un médicament à risque injectable
15	Audit système	Entretien Professionnel		
16	Traceur ciblé	Prévention des infections associées aux soins		Dialyse (surveillance des eaux, générateurs,..)
17	Patient traceur		Tout l'établissement Patient atteint d'un cancer Adulte Médecine Hospitalisation complète Programmé	
18	Patient traceur		Tout l'établissement Chirurgie et interventionnel Adulte Pas de situation particulière Hospitalisation complète Programmé	
19	Audit système	Entretien Professionnel		
20	Patient traceur		Tout l'établissement Chirurgie et interventionnel Adulte Pas de situation particulière Hospitalisation complète Programmé	
21	Audit système	Entretien Professionnel		
22	Traceur ciblé	Prévention des infections associées aux soins		Précautions standards et complémentaires avec dispositif invasif

23	Patient traceur		Tout l'établissement Chirurgie et interventionnel Adulte Pas de situation particulière Hospitalisation complète Programmé	
24	Patient traceur		Tout l'établissement Maladie chronique Adulte Médecine Hospitalisation complète Programmé	
25	Patient traceur		Tout l'établissement Ambulatoire Maternité Adulte Pas de situation particulière Programmé	
26	Patient traceur		Tout l'établissement Maternité Maladie chronique Adulte Hospitalisation complète Programmé	
27	Patient traceur		Tout l'établissement Ambulatoire Chirurgie et interventionnel Patient âgé Pas de situation particulière Programmé	

28	Patient traceur		Tout l'établissement Patient âgé Patient en situation de précarité Psychiatrie et santé mentale Hospitalisation complète Programmé	
29	Audit système	Entretien Professionnel		
30	Audit système	Coordination territoriale		
31	Parcours traceur		Tout l'établissement Chirurgie et interventionnel Patient atteint d'un cancer Patient âgé Adulte Hospitalisation complète Programmé	
32	Patient traceur		Tout l'établissement Adulte Médecine Pas de situation particulière Hospitalisation complète Programmé	
33	Audit système	Entretien Professionnel		
34	Audit système	Entretien Professionnel		
35	Audit système	QVT & Travail en équipe		
36	Patient traceur		Tout l'établissement Ambulatoire Adulte Médecine Pas de situation particulière	

			Programmé	
37	Audit système	Engagement patient		
38	Audit système	Leadership		
39	Audit système	Dynamique d'amélioration		
40	Audit système	Maitrise des risques		
41	Patient traceur		Tout l'établissement Enfant et adolescent Maternité Pas de situation particulière Hospitalisation complète Programmé	
42	Patient traceur		Tout l'établissement Adulte Médecine Pas de situation particulière Hospitalisation complète Programmé	
43	Traceur ciblé	Prélèvement et greffe d'organes et de tissus		na
44	Parcours traceur		Tout l'établissement Patient âgé Maladie chronique Adulte Médecine Hospitalisation complète Programmé	
	Patient traceur		Tout l'établissement Adulte	

45			Médecine Pas de situation particulière Hospitalisation complète Programmé	
46	Patient traceur		Tout l'établissement Ambulatoire Patient atteint d'un cancer Adulte Médecine Programmé	
47	Patient traceur		Tout l'établissement Patient âgé Maladie chronique Médecine Hospitalisation complète Programmé	
48	Patient traceur		Tout l'établissement Patient âgé Maladie chronique Médecine Hospitalisation complète Programmé	
49	Traceur ciblé	Prévention des infections associées aux soins		Antibioprophylaxie
50	Traceur ciblé	Accueil non programmé		Urgences Tenon
51	Patient traceur		Tout l'établissement Adulte Médecine Pas de situation particulière Hospitalisation complète	

			Programmé	
52	Traceur ciblé	Gestion des évènements indésirables graves		EIG ayant fait l'objet d'une déclaration à l'ARS ou d'un CREX en interne
53	Parcours traceur		Tout l'établissement Ambulatoire Patient âgé Patient en situation de handicap Maladie chronique Adulte Médecine Hospitalisation complète Programmé	
54	Parcours traceur		Tout l'établissement Ambulatoire Chirurgie et interventionnel Enfant et adolescent Maternité Patient en situation de handicap Patient en situation de précarité Urgences Adulte Hospitalisation complète	
55	Patient traceur		Tout l'établissement Ambulatoire Maladie chronique Adulte Médecine Programmé	
56	Patient traceur		Tout l'établissement Ambulatoire Patient âgé Maladie chronique	

			Médecine Programmé	
57	Patient traceur		Tout l'établissement Chirurgie et interventionnel Urgences Adulte Pas de situation particulière Hospitalisation complète	
58	Traceur ciblé	Gestion des événements indésirables graves		EIG ayant fait l'objet d'une déclaration à l'ARS ou d'un CREX en interne
59	Patient traceur		Tout l'établissement Chirurgie et interventionnel Adulte Pas de situation particulière Hospitalisation complète Programmé	
60	Parcours traceur		Tout l'établissement Patient âgé Patient en situation de handicap Maladie chronique Médecine Hospitalisation complète Programmé	
61	Traceur ciblé	Transport intra-hospitalier des patients		Transport entre le secteur de soins et le bloc - Patient couché
62	Traceur ciblé	Transport intra-hospitalier des patients		Transport entre le secteur de soins et le bloc - Patient couché
63	Traceur ciblé	Gestion des produits sanguins labiles		Priorisation de l'unité de soins où est réalisée la transfusion : Hématologie, Réanimation, USC, Oncologie, Orthopédie / Le type de produit est

				laissé à l'appréciation de l'EV
64	Audit système	Entretien Professionnel		
65	Parcours traceur		Tout l'établissement Ambulatoire Chirurgie et interventionnel Enfant et adolescent Patient âgé Adulte Pas de situation particulière Programmé	
66	Audit système	Représentants des usagers		
67	Audit système	Entretien Professionnel		
68	Traceur ciblé	Prévention des infections associées aux soins		Per opératoire (bloc)
69	Parcours traceur		Tout l'établissement Ambulatoire Chirurgie et interventionnel Patient âgé Adulte Pas de situation particulière Programmé	
70	Patient traceur		Tout l'établissement Patient en situation de handicap Adulte Médecine Hospitalisation complète Programmé	
	Patient traceur		Tout l'établissement Soins critiques	

71			Urgences Adulte Pas de situation particulière Hospitalisation complète	
72	Parcours traceur		Tout l'établissement Ambulatoire Chirurgie et interventionnel Maladie chronique Adulte Programmé	
73	Traceur ciblé	Prélèvement et greffe d'organes et de tissus		Priorisation de l'unité de soins où est réalisée la transfusion : Hématologie, Réanimation, USC, Oncologie, Orthopédie / Le type de produit est laissé à l'appréciation de l'EV

Retrouvez tous nos travaux sur
www.has-sante.fr

